

VISÃO DE PRODUTO E NEGÓCIO

Documentação de Produto

Funcionalidades, personas, jornadas e regras de negócio da clínica

Projeto	BemEstarClinic
Segmento	Clínica de psicanálise, psicologia, ozonioterapia e terapias integrativas
Local	Caruaru — PE
Versões analisadas	Site 1.20.0 · Gestão 1.28.0
Situação	Em produção
Data da análise	12 de agosto de 2026

Sumário

1. Visão geral do produto	3
1.1 O que é	3
1.2 Problemas que resolve	3
1.3 Público-alvo	3
1.4 Proposta de valor	3
2. Personas e perfis de acesso	5
2.1 Como nasce um acesso	5
3. A regra de negócio central	6
3.1 As quatro decisões que sustentam a regra	6
3.2 O caminho de volta: “finalizei errado”	6
4. Funcionalidades	8
4.1 Site público	8
4.2 Pannel de conteúdo (/admin)	8
4.3 Sistema de gestão (/restrito)	9
5. Anamneses	10
5.1 Tipos de pergunta disponíveis	10
5.2 Decisões de produto	10
6. Estados e transições	11
7. Regras de negócio	12
7.1 Agenda	12
7.2 Cadastros e histórico	12
7.3 Numeração	12
7.4 Conteúdo do site	13
8. Jornadas	14
8.1 Visitante que vira paciente	14
8.2 Recepção no dia a dia	14
8.3 Profissional em atendimento	14
8.4 Responsável pela clínica	14
9. Requisitos	15
9.1 Requisitos funcionais identificados	15
9.2 Requisitos não funcionais	16
10. Integrações	17
11. Limitações atuais	17

12. Situação de cada frente 18

12.1 Existe e está em uso 18

12.2 Parcialmente implementado 18

12.3 Perguntas do cliente ainda sem resposta 18

12.4 Sugestões — não implementadas 18

1. Visão geral do produto

1.1 O que é

O BemEstarClinic é, na prática, **três produtos que dividem a mesma porta**: um site institucional que capta pacientes, um painel que deixa a própria clínica editar esse site sem depender de programador, e um sistema de gestão clínica que substitui a ficha de papel por prontuário eletrônico.

Foram construídos em sequência, e essa ordem explica o produto: primeiro o site (v1.0 do site), depois o painel, e só então o sistema de gestão — que hoje é a peça com mais funcionalidade e mais versões.

1.2 Problemas que resolve

Problema	Como o produto resolve	Onde
A clínica dependia de terceiros para mudar qualquer texto ou foto do site	84 campos editáveis em 19 grupos, com publicação por um botão. Nenhum HTML é tocado	/admin
Ficha de paciente em papel: some, rasura, não busca, não acompanha o paciente	Cadastro com código próprio, busca por nome, código ou CPF, e histórico que sobrevive à saída e ao retorno do paciente	/restrito
Agenda de papel gera choque de horário e de sala	Validação no servidor: expediente, fim depois do início, sem choque de profissional e sem choque de sala	/restrito
Anamnese em .docx: cada profissional com sua versão, sem padrão e sem busca	Três modelos padronizados que geram a tela e a impressão a partir da mesma definição	/restrito
Prontuário disperso: cada sessão virava um documento solto	Uma pasta por paciente + procedimento, com lançamentos datados que nunca são excluídos, só arquivados	/restrito
Impressão sem identidade e sem valor documental	Papel timbrado com marca-d'água, cabeçalho repetido a cada quebra de página, numeração de controle e assinaturas	/restrito
"Quem mexeu nisto?" sem resposta possível	Trilha de auditoria com data, hora, IP, autor, ação e o antes/depois de cada edição	/restrito
Dado sensível de paciente exposto em qualquer cópia do banco	Criptografia na aplicação: um dump vazado não entrega CPF, endereço nem prontuário	/restrito

1.3 Público-alvo

Público	Superfície	O que busca
Pessoa procurando terapia ou terapia integrativa em Caruaru e região	Site público	Entender as especialidades, conhecer os profissionais e agendar
Empresa que precisa atender a NR-1 e riscos psicossociais	Site público (seção Para Empresas)	Avaliação psicossocial e saúde do trabalhador
Recepção da clínica	/restrito	Cadastrar, agendar, imprimir e retomar contato
Profissional de saúde	/restrito	Sua agenda, suas anamneses e seus prontuários
Responsável pela clínica	/restrito e /admin	Números do movimento, contas de acesso, auditoria e o conteúdo do site

1.4 Proposta de valor

- **A clínica é dona do próprio conteúdo.** Texto, foto, especialidade, profissional e matéria do blog mudam sem chamado técnico.
- **O prontuário acompanha o tratamento, não a sessão.** Um paciente que faz psicanálise e ozonioterapia tem duas pastas, cada uma com sua própria alta.

- **Nada se perde.** Cadastro com histórico não é excluído — é bloqueado, inativado ou arquivado. Lançamento clínico não é apagado — é arquivado, e editá-lo deixa rastro.
- **A impressão é o produto.** Boa parte do valor entregue sai em papel: ficha, anamnese, prontuário completo, agenda e relações. Tudo em papel timbrado.
- **Privacidade como requisito, não como promessa.** Dado sensível cifrado, IP do visitante pseudonimizado, retenção definida e recorte de acesso aplicado no servidor.

2. Personas e perfis de acesso

O sistema de gestão tem **três perfis**, definidos no código e aplicados no servidor — não apenas escondendo botões na tela.

Perfil	Quem é	O que faz	O que NÃO acessa
admin	Responsável pela clínica	Tudo. Além dos módulos comuns: Usuários do Sistema, Auditoria, Sobre o sistema, Backup do banco e o atalho para o painel do site	—
secretaria	Recepção	Pacientes, profissionais, convênios, procedimentos, salas, agendamento, documentos e relatórios. Pode cadastrar profissional (o que já cria o login dele) e bloquear acesso	Prontuário e anamnese — dado clínico sensível. Bloqueado no servidor: a tentativa responde 403
profissional	Psicanalista, psicólogo, terapeuta	Sua agenda, suas anamneses, seus prontuários e os lançamentos que ele mesmo escreveu. Lê pacientes, procedimentos, convênios e salas apenas como apoio dos seletores	Usuários do Sistema, auditoria, inativação de paciente, e tudo que pertence a outro profissional

FATO

O recorte do profissional mudou de regra em 28/07/2026 (versão 1.26.0 e migration 003). Antes, a *pasta* do prontuário era visível a todos os profissionais e só os *lançamentos* eram privados; as anamneses eram visíveis a todos. Hoje o profissional vê apenas o que é dele, em todas as telas, na impressão do prontuário completo e no histórico.

A migração que aplicou a regra preencheu o dono dos registros antigos casando pelo **nome** do profissional. O que não casou ficou sem dono — e registro sem dono **nenhum profissional vê**. O comentário justifica: esconder demais se conserta atribuindo a pasta; mostrar de menos não expõe prontuário de ninguém.

PONTO DE ATENÇÃO - verificação recomendada

Consequência operacional dessa escolha: se um prontuário antigo tinha o nome do profissional grafado de forma diferente do cadastro (um “Dr.” a mais, por exemplo), ele **ficou invisível para o próprio dono** e precisa ser reatribuído pelo administrador. É um efeito esperado da migração, não um defeito — mas alguém precisa verificar se aconteceu.

2.1 Como nasce um acesso

1. Cadastrar um profissional em **Cadastros -> Profissionais** já cria o login dele: os campos de login e senha ficam no próprio formulário.
2. **A secretaria pode fazer isso** — mas por essa porta só nasce conta de perfil *profissional*. Virar administrador continua exclusivo do módulo Usuários.
3. A situação do profissional (Ativo / Bloqueado) **espelha** na conta de acesso, e bloquear derruba a sessão aberta na hora.

3. A regra de negócio central

Esta é a regra que organiza o sistema inteiro. Ela foi definida pelo cliente e está implementada ponta a ponta, com validação no servidor.



Figura 1 — O caminho do paciente. A seta tracejada é o recolhimento retroativo dos agendamentos que estavam soltos.

3.1 As quatro decisões que sustentam a regra

Decisão	Por quê
O agendamento nunca abre prontuário	Marcar uma consulta não significa iniciar acompanhamento. O agendamento só se pendura numa pasta que já exista para aquele paciente naquele procedimento
Quem abre a pasta é a anamnese FINALIZADA	É o momento em que existe conteúdo clínico. Enquanto está em rascunho, a anamnese não cria nada e pode ser excluída
A chave da pasta é o NOME do procedimento, não o id da linha	“Ozonioterapia (Consulta)” e “Ozonioterapia (Sessão)” são duas linhas na tabela de procedimentos, mas o mesmo tratamento . Usar o id abriria duas pastas para a mesma terapia
Reabrir a anamnese não desfaz o prontuário	A pasta já pode ter lançamentos e agenda pendurados. Desfazer apagaria trabalho clínico por causa de uma correção de formulário

FATO

O campo que guarda a chave da pasta chama-se especialidade, por herança da primeira versão, mas **o que ele guarda é o nome do procedimento**. O rótulo na tela foi corrigido; o nome da coluna não. Está documentado no próprio esquema do banco.

3.2 O caminho de volta: “finalizei errado”

Uma regra que só anda para a frente prende o usuário no primeiro erro. Este ponto chegou a ser um impasse real no produto: com anamnese e agendamento contando como vínculo, a pasta não podia ser apagada — e a anamnese vinculada também não. Quem finalizasse por engano ficava com as duas presas para sempre.

A regra vigente hoje:

- **Só lançamento segura a pasta.** Anamnese e agendamento vinculados não impedem a exclusão.
- **Apagar a pasta solta o que estava nela:** a anamnese volta a rascunho, o agendamento fica sem prontuário, e ambos sobrevivem.
- Tudo isso é registrado no histórico.
- Pasta **com lançamento** responde 409 e sugere **Dar alta** em vez de excluir.

Ordem de exclusão, quando é realmente necessário limpar: lançamentos -> pasta -> anamneses -> agendamentos -> paciente.

4. Funcionalidades

4.1 Site público

Funcionalidade	Descrição	Situação
Página inicial	Nove seções: Especialidades, A Clínica, Profissionais, Atendimento Online, Para Empresas, Nosso Espaço, Depoimentos, Feed e Contato	Existente
Especialidades	Página índice + 16 páginas próprias , uma por especialidade, cada uma com URL própria	Existente
Guia de profissionais	Página com os 9 profissionais , especialidades que atendem e WhatsApp individual de cada um	Existente
Feed / Blog	3 matérias publicadas, com página própria e capa	Existente
Nosso Espaço	Galeria com 7 fotos da clínica	Existente
Depoimentos	6 depoimentos	Existente
SEO e compartilhamento	Título ajustado à faixa de exibição do buscador, cartão de compartilhamento por matéria, dados estruturados e hierarquia de títulos correta	Existente (v1.20.0)
Agendar consulta	Formulário que monta a mensagem de WhatsApp, com busca de CEP que preenche o endereço	Existente
Busca no site	Índice de busca gerado na publicação (assets/data/search-index.json)	Existente
Política de privacidade	Página própria, com o encarregado de dados identificado	Existente
Contato	Formulário, WhatsApp flutuante, mapa e horário de atendimento	Existente
Medição de audiência	Estrutura para GA4, GTM, Pixel, Clarity e Hotjar, condicionada ao aceite do cookie	Estrutura pronta, IDs vazios

4.2 Painel de conteúdo (/admin)

Tela	O que permite
Publicar	Regenera o site. Também abriga o modo manutenção , com título e texto editáveis
Acessos	Estatísticas de visita do site público
A clínica -> Especialidades	Cadastro das especialidades, cada uma com texto longo e página própria
A clínica -> Profissionais	Nome, função, biografia, foto, WhatsApp, especialidades que atende e se aparece na home
A clínica -> Nosso Espaço	Galeria de fotos da clínica
Conteúdo -> Blog	Matérias com título, resumo, conteúdo, capa e data
Conteúdo -> Depoimentos	Depoimentos com texto, nome, função e iniciais
Textos do site	Os 84 campos em 19 grupos — a tela é montada a partir da declaração no servidor, não escrita à mão
Senha	Troca da senha do painel

PONTO DE ATENÇÃO - comportamento que gera dúvida

Editar não publica. Alterar texto ou foto grava no banco, mas o site continua mostrando a versão anterior até alguém clicar em **Publicar**. É a confusão operacional mais provável deste painel.

4.3 Sistema de gestão (/restrito)

Módulo	Objetivo	Usuário	Entradas principais	Saídas
Painel	Números do dia	todos	—	Indicadores da tela inicial
Pacientes	Ficha completa da recepção	admin, secretaria	Dados pessoais, endereço com busca de CEP, responsável, convênio, consentimento	Código PAC, ficha impressa, relação de ativos/inativos
Profissionais	Quem atende e o que realiza	admin, secretaria	Nome, registro, contato, cor da agenda, procedimentos que realiza, login e senha	Login criado, situação Ativo/Bloqueado
Convênios	Formas de pagamento aceitas	admin, secretaria	Nome, registro, contato	Lista para o agendamento
Procedimentos	O que se agenda	admin, secretaria	Nome, tipo (Consulta/Sessão/Procedimento), valor, duração, cor e modelo de anamnese que pede	Etiqueta colorida na agenda; atalho de anamnese
Salas	Consultórios	admin, secretaria	Nome	Validação de choque de sala
Anamneses	Entrevista clínica padronizada	admin, profissional	Um dos três modelos; dados pessoais preenchidos sozinhos a partir do cadastro	Documento impresso; ao finalizar, abre o prontuário
Agendamento	Agenda da clínica	admin, secretaria, profissional	Paciente, profissional, sala, convênio, procedimento, data, início e fim	Três vistas, agenda impressa em paisagem
Prontuário	Pasta por paciente + procedimento	admin, profissional	Avaliações, evoluções, planos terapêuticos e encaminhamentos, datados	Pasta impressa, prontuário completo, evolução isolada
Documentos	Anexos por paciente	admin, secretaria	Tipo, título, arquivo	Arquivo servido só com sessão
Relatórios	Movimento e relação de pacientes	admin, secretaria	Filtro por período; filtro Ativos/Inativos/Todos	Painel de movimento; relação com endereço, WhatsApp, quem assiste e especialidades
Arquivados	Recuperar o que saiu da lista	admin	—	Restauração com um clique
Auditoria	Quem fez o quê	admin	Filtros de período, pessoa, ação e módulo	Trilha com antes/depois campo a campo
Sobre o sistema	Versão e histórico	admin	—	Versão, changelog em sanfona, tecnologias e banco ativo
Usuários	Contas de acesso	admin	Nome, e-mail, perfil, senha	Contas com perfil

5. Anamneses

As anamneses são o coração da entrega clínica. Os três modelos vieram de documentos .docx do cliente e foram traduzidos para uma **definição única** que gera, ao mesmo tempo, o formulário na tela e a versão impressa.

Modelo	Rótulo na tela	Seções	Campos
psicanalise	Psicanálise	9	Motivo da consulta · História do desenvolvimento · Dinâmica familiar · História médica · Saúde emocional · Histórico familiar · Personalidade · Memórias importantes · Complemento
ozonio	Ozonioterapia	8	Motivo da consulta · Check-list médico · Contraindicações · Medicamentos em uso · Hábitos de vida · Histórico familiar · Avaliação física · Indicação do tratamento
integrativas	Terapias Integrativas	10	Motivo da consulta · Histórico de saúde · Cirurgias · Medicamentos · Alergias · Hábitos · Histórico familiar · Contraindicações importantes · Avaliação · Terapias aplicadas

São **27 seções e 89 campos** no total, incluindo sete matrizes de marcação.

5.1 Tipos de pergunta disponíveis

Tipo	Comportamento
text · textarea · number	Resposta livre, curta ou longa
radio	Escolha única entre opções fixas
check	Múltipla escolha
simnao	Par Sim/Não, com marcação exclusiva
matriz	Grade de linhas × colunas de caixas. Usada em histórico familiar (condição × parente) e em contraindicações
lista	Linhas que o próprio usuário acrescenta — medicamentos, cirurgias

5.2 Decisões de produto

- **Acrescentar pergunta não exige mexer no banco.** As respostas ficam num campo JSON; basta editar o modelo. Isso torna a evolução do formulário uma tarefa de minutos, e não uma migração de esquema.
- **Escolher o paciente preenche o bloco de dados pessoais** a partir do cadastro — pedido explícito do responsável clínico. Vale na tela e na impressão.
- **Cada procedimento aponta o modelo que pede.** É o que faz o agendamento oferecer o atalho “Preencher anamnese” já no formulário certo. O campo é editável no cadastro de Procedimentos: procedimento novo não exige mexer no código.
- **Anamnese finalizada é documento fechado** — campos e botão Salvar travados até ser reaberta.
- **Anamnese com vínculo não se exclui**, mesmo reaberta. A regra é ter prontuário, não estar em rascunho — senão daria para apagar a anamnese que abriu a pasta.

6. Estados e transições

Três entidades do sistema têm ciclo de vida próprio. **Os três conceitos são diferentes e essa distinção é deliberada** — misturá-los destruiria informação de trabalho.

Conceito	Sobre o quê	O que afirma	Efeito na tela
Ativo / Inativo	A PESSOA	O paciente deixou a clínica. É fato do acompanhamento	Some dos seletores, continua na lista com etiqueta. A relação de inativos serve para retomar contato
Ativo / Alta	A PASTA do prontuário	O acompanhamento <i>naquela especialidade</i> terminou. Alta da ozonioterapia, segue na psicanálise	Fica à vista, com faixa de situação e opção de reabrir
Arquivado	Paciente, pasta ou lançamento	Nada sobre a pessoa nem sobre o tratamento. Diz apenas "tire isto da minha frente"	Some da lista, volta num clique pela tela Arquivados

FATO

Se “arquivar” reaproveitasse o campo “ativo”, arquivar alguém passaria a **afirmar** que a pessoa deixou a clínica — e a relação de inativos, que a recepção usa para ligar de volta, encheria de gente que só foi arquivada por poluição de lista. O raciocínio está escrito na própria migração.

PACIENTE



PRONTUÁRIO (a pasta)



ANAMNESE



Figura 2 — Estados e transições das três entidades com ciclo de vida.

7. Regras de negócio

Regras identificadas no código, no banco e na interface. Todas são aplicadas no servidor, não apenas na tela.

7.1 Agenda

Regra	Detalhe
Só paciente cadastrado	Garante que todo atendimento tenha ficha, código e histórico
Expediente 06h – 22h	Fora disso, o horário é recusado
Fim depois do início	Ambos obrigatórios
Fim sugerido pela duração	O fim é sempre recalculado a partir do início e da duração do procedimento; sem procedimento, 40 minutos. Ajuste manual sobrevive até mexerem no início ou no procedimento
Sem choque de profissional	Duas marcações no mesmo horário para a mesma pessoa são recusadas
Sem choque de sala	Mesma validação para o consultório
Cancelado não bloqueia	Horário de atendimento cancelado volta a ficar livre
Ordenação por data e hora	É como a recepção lê o dia
Procedimento recortado pelo profissional	O seletor mostra apenas o que o profissional escolhido realiza. Lista vazia não restringe

FATO

A última regra gerou um chamado real: o cliente cadastrou procedimentos, eles apareceram no ambiente local e não em produção. A causa não era código, era **dado** — em produção os profissionais tinham lista de procedimentos preenchida, e o novo não estava nela. Hoje o seletor **explica** a ausência: “N procedimento(s) existem mas não aparecem porque <profissional> não os realiza”, e indica o caminho para corrigir.

7.2 Cadastros e histórico

Regra	Detalhe
Cadastro com histórico não se exclui	Vale para profissionais, pacientes, procedimentos, convênios e salas. A tentativa responde 409 listando os vínculos (“1 atendimento, 1 anamnese...”) e sugere Bloquear . Apagar deixaria a agenda antiga sem profissional e o prontuário impresso sem procedimento
Cadastro sem vínculo ainda pode ser excluído	Profissional sem vínculo é excluído junto com o acesso dele
Editar lançamento deixa rastro	O servidor guarda o estado anterior, compara e grava no histórico o trecho que mudou, além de alteração de data e de profissional. Salvar sem mudar nada não gera linha
Lançamento nunca é excluído	Só arquivado, com data de arquivamento
Paciente inativo bloqueia registro NOVO	Agendar, criar anamnese e abrir prontuário são barrados, com mensagem que ensina a reativar. Editar o que já existe continua liberado : o passado não se mexe pela situação de hoje
Inativo some do seletor mas continua no cache	Senão o nome dele desapareceria de agendamentos e prontuários antigos

7.3 Numeração

Número	Formato	Identifica	Regras
Código do paciente	PAC - AAAA - 00000	A pessoa	Sequencial por ano, único, gerado pelo servidor, nunca digitado
Número do prontuário	PR - AAAA - 00000	A pasta	Sequencial por ano, único, gerado no servidor e nunca editável . Número de registro excluído não é reaproveitado

O número da pasta aparece em tudo que é vinculado ao paciente: anamnese, agendamento e documentos exibem os “chips” com o número das pastas daquele paciente.

7.4 Conteúdo do site

- Publicar é um passo explícito — editar não altera o site no ar.
- Slug de especialidade e de matéria é derivado do título, e recebe sufixo se colidir.
- Alguns textos são **fixos de propósito**: rótulos do formulário de contato e links de navegação, porque estão amarrados às âncoras e ao nome que monta a mensagem de WhatsApp.
- Upload aceita apenas imagem rasterizada — SVG é recusado por segurança.

8. Jornadas

8.1 Visitante que vira paciente

```
busca no Google -> página da especialidade -> conhece o profissional
-> "Agendar consulta" -> formulário (com busca de CEP)
-> mensagem montada no WhatsApp -> recepção responde
-> cadastro no sistema -> código PAC gerado
```

8.2 Recepção no dia a dia

1. Abre **Agendamento** e lê o dia (ordenado por data e hora, com etiqueta colorida por procedimento).
2. Paciente novo: cadastra em **Pacientes**, com CEP preenchendo o endereço.
3. Marca o atendimento — o sistema valida expediente, choque de profissional e choque de sala.
4. Imprime a agenda em paisagem, ou a relação de pacientes inativos para retomar contato.

A recepção **não vê** anamnese nem prontuário. É bloqueio de servidor, não de tela.

8.3 Profissional em atendimento

1. Entra e vê **apenas a própria agenda**.
2. No agendamento salvo, usa o atalho **Preencher anamnese**, que já abre o modelo que aquele procedimento pede.
3. O bloco de dados pessoais vem preenchido do cadastro; o profissional também vem pré-preenchido quando quem está logado é um profissional.
4. **Finaliza** a anamnese — o prontuário nasce e recolhe os agendamentos soltos daquele par paciente + procedimento.
5. Nas sessões seguintes, lança **evoluções** datadas dentro da pasta.
6. Ao encerrar o tratamento naquela especialidade, **dá alta** na pasta.

8.4 Responsável pela clínica

1. Acompanha **Relatórios -> Movimento da clínica**, com filtro de período.
2. Cria e bloqueia contas em **Usuários do Sistema**.
3. Consulta a **Auditoria** quando precisa saber quem alterou o quê.
4. Baixa o **backup do banco** sob demanda.
5. Usa o atalho de nove pontos para abrir o **painel do site** já autenticado, e edita o conteúdo sem digitar outra senha.

9. Requisitos

9.1 Requisitos funcionais identificados

ID	Requisito	Situação
RF-01	Editar todo o conteúdo textual e visual do site sem alterar código	Implementado
RF-02	Publicar o site como páginas estáticas a partir do conteúdo gravado	Implementado
RF-03	Colocar o site em manutenção sem interromper o atendimento da equipe	Implementado
RF-04	Medir visitas ao site sem armazenar IP em texto claro	Implementado
RF-05	Cadastrar paciente com a ficha usada pela recepção, com código próprio gerado	Implementado
RF-06	Localizar paciente por nome, código ou CPF, com ou sem máscara	Implementado
RF-07	Preencher endereço automaticamente a partir do CEP	Implementado
RF-08	Agendar validando expediente, choque de profissional e choque de sala	Implementado
RF-09	Registrar anamnese em três modelos padronizados	Implementado
RF-10	Abrir prontuário ao finalizar a anamnese, um por paciente + procedimento	Implementado
RF-11	Registrar lançamentos clínicos datados, com arquivamento em vez de exclusão	Implementado
RF-12	Registrar no histórico o trecho alterado ao editar um lançamento	Implementado
RF-13	Dar alta e reabrir prontuário por especialidade	Implementado
RF-14	Inativar e reativar paciente sem apagar a ficha	Implementado
RF-15	Arquivar e restaurar paciente, pasta e lançamento	Implementado
RF-16	Imprimir em papel timbrado: ficha, anamnese, prontuário completo, evolução isolada, agenda e relações	Implementado
RF-17	Escolher retrato ou paisagem em qualquer impressão	Implementado
RF-18	Controlar acesso por perfil, aplicado no servidor	Implementado
RF-19	Criar o login do profissional no próprio cadastro dele	Implementado
RF-20	Bloquear acesso derrubando a sessão aberta	Implementado
RF-21	Registrar trilha de auditoria com antes e depois	Implementado
RF-22	Emitir backup do banco sob demanda e automaticamente	Implementado
RF-23	Impedir exclusão de cadastro que já tem histórico	Implementado
RF-24	Relacionar pacientes ativos e inativos com dados de contato	Implementado
RF-25	Paginar todas as listagens	Implementado
RF-26	Filtrar por período em anamneses, agenda e relatórios	Implementado

9.2 Requisitos não funcionais

Listados apenas os que são observáveis no código ou justificáveis pela implementação.

Categoria	Requisito atendido	Evidência
Segurança	Senhas com derivação lenta e sal individual	bcrypt N=16384, comparação em tempo constante
	Freio contra adivinhação de senha, por IP e por conta	limitador.js, com estado persistido
	Sem enumeração de usuário por tempo de resposta	Hash-isca no login da gestão
	Isolamento entre painel e gestão	Cookies com Path próprio; travessia só para admin
	Proteção contra XSS armazenado	Lista fechada de tags; upload sem SVG; CSP nas duas áreas autenticadas
Privacidade (LGPD)	Dado sensível cifrado em repouso	AES-256-GCM aplicado pela aplicação
	IP do visitante pseudonimizado	Hash com sal por instalação
	Prazo de retenção definido	12 meses para registros de visita, com limpeza automática
	Áreas com dado de paciente fora dos buscadores	noindex, nofollow e Disallow no robots
	Anexo de paciente só com sessão	Servido com no-store e noindex
Disponibilidade	Falha do banco da gestão não derruba o site	Boot tolerante + religação automática
	Página de manutenção mesmo com a aplicação fora do ar	error_page no nginx
	Cópia de segurança diária com conferência de integridade	backup.js, 30 cópias por banco
Integridade	Numeração sem duplicata e sem reaproveitamento	Contador persistente + índice único parcial
	Esquema do banco versionado e transacional	migrations/, com registro em schema_migrations
Usabilidade	Mensagem de erro que ensina o caminho	Seletor que explica ausência de procedimento; 404 traduzido para "serviço não reiniciado"
	Botões travam durante o processamento	Evita duplicidade por clique repetido
Responsividade	Site adapta a desktop, tablet e celular	14 pontos de quebra no CSS; menu, busca e cartões reorganizados
Qualidade	Nenhuma entrega sem suíte verde	Pipeline com portão de prova

10. Integrações

Integração	Valor para o produto	Impacto se indisponível
ViaCEP + BrasilAPI	Endereço preenchido sozinho no cadastro, no formulário do site e no painel. Reduz erro de digitação e tempo de recepção	Baixo — o endereço volta a ser digitado à mão, com aviso na tela
WhatsApp	É o canal real de agendamento. O formulário do site monta a mensagem pronta, incluindo o endereço	Alto para captação — é o caminho principal de contato
Google Maps	Localização na seção de contato	Baixo
Doctoralia	Canal alternativo de agendamento	Baixo
Google Fonts	Identidade tipográfica	Baixo — fonte de sistema assume
Unsplash	Fotos do topo, atendimento online e capas do blog	Médio para a aparência do site

RECOMENDAÇÃO

As fotos do topo, do atendimento online e as três capas do blog ainda são de banco de imagens. Substituí-las por fotos reais da clínica e da equipe aumenta a conversão e a credibilidade — é a melhoria de produto de menor esforço e maior efeito visível hoje.

11. Limitações atuais

Limitação	Consequência prática
Não há portal do paciente	O paciente não acessa nada: não confirma consulta, não vê histórico, não recebe documento pelo sistema
Agendamento não é self-service	O visitante preenche um formulário que vira mensagem de WhatsApp; quem marca de fato é a recepção
Sem envio automático de lembrete	As colunas lembrete e nps existem na agenda, mas nenhum disparo é feito pelo sistema
Sem controle financeiro	Há campo de valor no procedimento e no atendimento, mas não há contas a receber, faturamento por convênio nem fechamento de caixa
Sem faturamento TISS / integração com operadora	Convênio é apenas um cadastro de referência
Sem visão de agenda com todos os profissionais lado a lado	A agenda é filtrada por um profissional por vez — foi escolha do cliente, não limitação técnica
Relatórios são de movimento e de relação	Não há indicadores de ocupação, taxa de absenteísmo, retorno ou receita
Backup só dentro do servidor	Cobre erro humano e corrupção, não perda da máquina
Medição de audiência inativa	Não há dado de origem de tráfego nem de conversão do site
Impressão depende do navegador	Não há geração de PDF pelo servidor; o resultado varia conforme o navegador e as opções de impressão do usuário

12. Situação de cada frente

Separação explícita entre **o que existe**, **o que está parcialmente implementado** e **o que é sugestão**. Nada abaixo da terceira faixa está construído.

12.1 Existe e está em uso

- Site institucional completo, com 16 páginas de especialidade e blog.
- Painel de conteúdo com 84 campos, publicação e modo manutenção.
- Sistema de gestão com 15 telas, três perfis e a regra de negócio ponta a ponta.
- Três modelos de anamnese, com 27 seções e 89 campos.
- Seis tipos de impressão em papel timbrado.
- Criptografia de dado sensível, auditoria, arquivamento e backup diário.

12.2 Parcialmente implementado

Frente	O que existe	O que falta
Lembrete de consulta	Colunas Lembrete e nps na agenda, marcáveis no formulário	Nenhum envio. Não há integração de mensagem nem agendamento de disparo
Valores	Campo de valor no procedimento e no atendimento	Nenhum relatório financeiro, fechamento ou controle de recebimento
Medição do site	Estrutura de carregamento condicionada ao aceite do cookie	IDs das ferramentas estão vazios — nada é medido hoje
Documentos do paciente	Anexo com tipo, título e arquivo, servido com sessão	Sem modelos de documento, sem geração assistida, sem assinatura
Restauração de backup	Script restaurar .sh testado, com conferência de integridade e confirmação digitada	Nunca ensaiada no servidor real

12.3 Perguntas do cliente ainda sem resposta

Registradas no projeto e **não** respondidas até a data desta análise. Nenhuma bloqueia o uso:

- Como a equipe prefere localizar procedimentos — vale separar “só consultas / só sessões”?
- A agenda deve mostrar profissionais em tela dupla, ou um por vez está adequado?
- Há interesse na impressão conjunta de clínica e instituto?

12.4 Sugestões — não implementadas

RECOMENDAÇÃO

Tudo nesta seção é **proposta**. Nada aqui existe no sistema hoje.

Sugestão	Por que faria diferença	Porte
Fotos reais no lugar das de banco de imagens	Credibilidade e conversão do site; hoje o topo e o blog usam imagem genérica	Pequeno
Ligar a medição de audiência	Sem ela não se sabe de onde vem o paciente nem o que converte. A estrutura já existe	Pequeno
Envio de lembrete de consulta	As colunas já estão no banco. Reduziria falta em consulta, que é perda direta de receita	Médio
Backup externo com criptografia	Hoje a perda da máquina é perda de tudo. É a maior exposição operacional do produto	Médio
Confirmação de presença pelo paciente	Complementa o lembrete e alimenta o indicador de absenteísmo	Médio

Sugestão	Por que faria diferença	Porte
Indicadores de ocupação e absenteísmo	Os dados já estão na agenda; falta a leitura	Médio
Módulo financeiro	Campo de valor já existe, mas não há visão de receita por convênio ou por profissional	Grande
Portal do paciente	Mudaria a natureza do produto: exigiria autenticação de paciente, base legal específica e revisão completa de privacidade	Grande

FATO

Nota de método. Toda funcionalidade descrita neste documento foi verificada no código-fonte. Requisitos não foram inventados: os funcionais correspondem a comportamento implementado, e os não funcionais só entraram na lista quando havia evidência no código. As sugestões estão isoladas no item 12.4 e em caixas de recomendação, e nenhuma delas está construída. As contagens de conteúdo (16 especialidades, 9 profissionais, 3 matérias, 7 fotos, 6 depoimentos) vêm do banco do ambiente analisado — em produção podem diferir, porque são editáveis pela própria clínica.

PONTO DE ATENÇÃO - alvo em movimento

Estado capturado. Durante esta análise o site passou de 1.19.0 para **1.20.0**, com uma rodada de SEO e compartilhamento. O documento reflete esse estado. O sistema de gestão permanece em 1.28.0.